



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA



PANDUAN PEMULANGAN PASIEN

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor 319.36/I-PND/IGD/IV/2025

Tentang
Panduan Pemulangan Pasien

Disusun oleh :
Penanggung Jawab TIM AKP



(Afni Nur Ainy, S.Kep., Ns)

Disetujui oleh :
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M.Kes AFP)

Ditetapkan oleh :
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(dr. Nur Mazidah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Panduan Pemulangan Pasien dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kubutuhan RS. Prima Husada. Panduan Pemulangan Pasien ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2025 meliputi alur, wewenang dan tanggung jawab pemulangan pasien dalam pelayanan di rumah sakit.

Kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik.Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Panduan Pemulangan Pasien ini, dapat meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit Prima Husada.

Malang, 04 April 2025
Direktur RS Prima Husada



dr. Nur Mazidah

TIM PENYUSUN
PANDUAN PEMULANGAN PASIEN

Pengarah :

1. Dr. dr. Aslichah, M.Kes, AFP

Pelaksana :

1. dr. Nur Mazidah
2. Afni Nur Ainy, S.Kep., Ns
3. Ratih Aji Suryamanjari, S.Kep., Ns
4. Murwani Suryaning Sapartinah, A.Md. Kep
5. Ferianto Hendri Cahyono, AMd. Kep

DAFTAR ISI

SAMPUL

LEMBAR PENGESAHAN i

KATA PENGANTAR.....ii

TIM PENYUSUNiii

DAFTAR ISI.....iv

PERATURAN DIREKTUR v

BAB I DEFINISI 1

 1.1 Latar Belakang 1

BAB II RUANG LINGKUP 2

BAB III TATA LAKSANA..... 3

 3.2 Tata Laksana..... 3

BAB IV EVALUASI..... 8

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR 319.36/I-PND/IGD/IV/2025**

**TENTANG
PANDUAN PEMULANGAN PASIEN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kesinambungan pelayanan dan asuhan pasien, salah hal penting yang harus persiapan adalah pemulangan pasien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada tentang Panduan Pemulangan Pasien.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan
4. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor: 263/DPM/I-KEP/DIR/I/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang
5. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 390/I-KEP/DIR/V/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PANDUANPEMULANGAN PASIEN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pemulangan pasien adalah proses dalam kesinambungan pelayanan/asuhan pasien setelah rawat inap.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.
- (3) Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.

BAB II PERENCANAAN PEMULANGAN PASIEN

Pasal 2

- (1) Sebagian proses pemulangan pasien ada yang membutuhkan perencanaan pemulangan pasien yang dilaksanakan sejak asesmen awal rawat inap;
- (2) Perencanaan pemulangan pasien termasuk pemberian pelatihan khusus yang dibutuhkan pasien dan keluarga untuk kesinambungan asuhan pasien setelah meninggalkan rumah sakit.
- (3) Kriteria pemulangan pasien sesuai kondisi Kesehatan
- (4) Kriteria pasien yang memerlukan kesinambungan asuhan dirumah beserta edukasinya (terdapat di Form Ringkasan Pulang)
- (5) Tindak Lanjut pemulangan pasien yang memerlukan rujukan kepada fasilitas pelayanan kesehatan primer atau mandiri sesuai domisili pasien.

Pasal 3

- (1) Pasien rawat inap yang memerlukan perencanaan pemulangan pasien, antara lain dengan kriteria:
 - a. Usia lanjut;
 - b. Adanya gangguan mobilitas;
 - c. Masih memerlukan asuhan medis atau keperawatan;
 - d. Memerlukan bantuan untuk aktivitas sehari-harinya.
- (2) Perencanaan pemulangan pasien difasilitasi oleh Manajer Pelayanan Pasien untuk koordinasi agar terbentuk perencanaan pemulangan pasien yang terintegrasi antar para Profesional Pemberi Asuhan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 04 April 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



dr. Nur mazidah

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA
NOMOR : 319.36/IPND/IGD/IV/2025
PANDUAN PEMULANGAN PASIEN

BAB I
DEFINISI

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pemulangan pasien (*discharge planning*) adalah suatu proses sistematik untuk perkiraan, persiapan dan koordinasi yang dilakukan staf klinis untuk memfasilitasi kesinambungan asuhan pasien setelah rawat inap.

Discharge planning juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan harus sudah dimulai sejak awal pasien masuk ke rumah sakit (untuk rawat inap yang telah direncanakan sebelumnya / elektif) dan sesegera mungkin pada pasien-pasien non-elektif.

BAB II

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Panduan Tentang Pemulangan Pasien meliputi : emergency, rawat jalan, rawat inap, ruang tindakan, ruang perawatan khusus (ICU, HCU, Hemodialisis).

BAB III
TATALAKSANA

3.2 TATA LAKSANA

1. Asesmen awal saat pasien masuk rumah sakit.
 - a. Identifikasi, persiapan, dan rancang *discharge planning*
 - b. Peninjauan ulang rekam medis pasien (anamnesis, hasil pemeriksaan fisik, diagnosis dan tatalaksana)
 - c. Lakukan anamnesis: Identifikasi alasan pasien dirawat, termasuk masalah sosial dan perubahan terkini
 - d. Asesmen kebutuhan perawatan pasien berdasarkan kondisi dan penyakit yang dideritanya
 - e. Asesmen mengenai kemampuan fungsional pasien saat ini, misalnya fungsi kognitif, mobilitas.
 - f. Asesmen mengenai kondisi keuangan dan status pendidikan pasien
 - g. Asesmen mengenai status mental pasien
 - h. Asesmen mengenai kondisi rumah / tempat tinggal pasien
 - i. Tanyakan mengenai medikasi terkini yang dikonsumsi pasien saat di rumah
 - j. Identifikasi siapa pendamping utama/ penanggung jawab perawatan pasien
 - k. Diskusikan mengenai kebutuhan pasien dan pendamping utama/ penanggung jawab perawatan pasien
 - l. Tanyakan mengenai keinginan / harapan pasien atau keluarganya
 - m. Libatkanlah mereka dalam perencanaan *discharge planning* (karena pasien yang paling tahu mengenai apa yang dirasakannya dan ingin dirawat oleh siapa)
 - n. Gunakanlah bahasa awam yang dimengerti oleh pasien dan keluarganya
 - o. Setelah asesmen pasien dilakukan, tim *discharge planner*/ DPJP, PPJP dan Karu akan berdiskusi dengan tim multidisipliner mengenai:
Asesmen risiko : pasien dengan risiko tinggi membutuhkan *discharge planning* yang baik dan adekuat. Berikut adalah kriteria pasien risiko tinggi:
 1. Usia ≥ 65 tahun
 2. Tinggal sendirian tanpa dukungan sosial secara langsung
 3. Stroke, Serangan jantung, PPOK, Gagal jantung kongestif, Emfisema, Demensia, Alzheimer, AIDS, atau penyakit dengan potensi mengancam nyawa lainnya
 4. Pasien berasal dari panti jompo
 5. Alamat tidak diketahui atau berasal dari luar kota
 6. Tunawisma
 7. Dirawat kembali dalam 30 hari
 8. Percobaan bunuh diri
 9. Pasien tidak dikenal / tidak ada identitas
 10. Korban dari kasus kriminal
 11. Trauma multipel
 12. Tidak bekerja / Tidak ada asuransi
 - p. Identifikasi dan diskusi pilihan perawatan apa yang tersedia untuk pasien
 - q. Verifikasi availabilitas tempat perawatan pasien setelah pulang dari rumah sakit
2. Saat di ruang rawat inap:
 - a. Tetapkan prioritas mengenai hal-hal yang dibutuhkan oleh pasien dan keluarga
 - b. Gunakan pendekatan multi disiplin dalam menyusun perencanaan dan

- tatalaksana pasien
- c. DPJP dan PPJA di ruangan harus memastikan pasien memperoleh perawatan yang sesuai dan adekuat serta proses *discharge planning* berjalan lancar.
 - d. DPJP, PPJA dan Karu, harus memahami mengenai *discharge planning*.
 - e. Tugas PPJA, Karu adalah:
 1. mengkoordinasi semua aspek perawatan pasien termasuk *discharge planning*, asesmen, dan peninjauan ulang rencana perawatan
 2. memastikan semua rencana berjalan dengan lancar
 3. mengambil tindakan segera bila terdapat masalah.
 4. Mendiskusikan dengan pasien mengenai perkiraan tanggal pemulangan pasien dalam 24 jam setelah pasien dirawat
 5. Identifikasi, melibatkan, dan menginformasikan pasien mengenai rencana keperawatan, pastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan khusus pasien terpenuhi
 6. Catat semua perkembangan ke dalam rekam medis pasien
 7. Finalisasi *discharge planning* pasien 48 jam sebelum pasien dipulangkan, dan konfirmasi dengan pasien dan keluarga / PJ Perawatan pasien
 - f. Berikut adalah beberapa peralatan tambahan yang diperlukan pasien sepulangnya dari rumah sakit (bila diperlukan):
 1. Peralatan yang portabel dan sederhana: mudah digunakan, instruksi penggunaan minimal. Contoh: tongkat, toilet duduk.
 2. Peralatan yang membutuhkan pelatihan mengenai cara menggunakannya. Contoh: tempat tidur khusus, pegangan terfiksasi (*grab rails*), oksigen
 3. Kursi roda (manual dan listrik)
 - g. Pilihan transportasi yang dapat digunakan adalah:
 1. Ambulans
 2. Mobil pribadi
 3. Helikopter (bila diperlukan): biasanya digunakan untuk pasien dengan penyakit akut yang berat dan harus ditransfer ke rumah sakit lain
 4. Taksi
 - h. Identifikasi dan latihlah professional kesehatan yang dapat merawat pasien serta lakukan koordinasi dengan tim multidisiplin dalam merancang *discharge planning* pasien.
 - i. Yang dimaksud tim mutidisiplin ini adalah para professional kesehatan dari disiplin ilmu yang berbeda-beda, seperti pekerja sosial, perawat, terapis, dokter.
 - j. Lakukan diskusi dengan pasien dan keluarga mengenai alasan pasien dirawat, tatalaksana, prognosis, dan rencana pemulangan pasien.
 - k. Tanyakan kepada pasien: 'Anda ingin dirawat oleh siapa sepulangnya dari rumah sakit?
 - l. Biasanya pasien akan memilih untuk dirawat oleh anggota keluarganya.
 - m. Tanyakan kepada keluarganya mengenai kesediaan mereka untuk merawat pasien. Pastikan mereka diinformasikan mengenai Berikanlah mereka waktu untuk memutuskan.
 - n. Berikut adalah hal-hal yang harus diketahui oleh pemberi layanan perawatan pasien sepulangnya dari rumah sakit / *carer*(biasanya keluarga):
 1. Rencana pemulangan pasien secara tertulis dan lisan
 2. Kondisi medis pasien
 3. Hak *carer* untuk memperoleh asesmen

4. Penjelasan mengenai seperti apa terlibat dalam perawatan pasien
5. Keuntungan yang didapat
6. Dampak finansial
7. Akses penerjemah untuk memungkinkan komunikasi dan pemahaman yang efektif
8. Pemberitahuan mengenai kapan pasien akan dipulangkan
9. Pengaturan transportasi
10. Demonstrasikan cara menggunakan peralatan tertentu sebelum pasien dipulangkan dan pastikan terdapat jadwal pengecekan alat yang rutin.
11. Aturlah jadwal pertemuan berikutnya dengan pasien dan Pendamping/ PJ Perawatan pasien.

Tabel Asesmen dan Rencana Perawatan oleh MPP

Kebutuhan Pendamping pasien	Tindakan	Oleh siapa dan kapan
Tugas asuhan keperawatan		
Bagaimana mencari saran dan bantuan		
Informasi mengenai perawatan		
Informasi mengenai gangguan jiwa		
Keterlibatan dalam perencanaan perawatan dan Tatalaksana		
Dukungan untuk pendamping pasien/ perawatan pasien		
Hubungan dengan pasien		
Keluarga dan teman		
Uang		
Kesehatan pendamping pasien		
Risiko dan keamanan		
Pilihan perawatan		
Masalah lainnya		

*lampirkan satu salinan di rekam medis pasien dan berikan salinan lainnya kepada pendamping pasien

- o. Jika pasien menolak keterlibatan keluarga dalam diskusi, MPP harus memberitahukannya kepada keluarga dan menghargai keinginan pasien.
 - p. Jika terdapat konflik antara keinginan pasien dan keluarganya dalam merancang *discharge planning*, MPP harus melakukan peninjauan ulang mengenai rencana perawatan dan mencari solusi realistis dari masalah yang timbul. Salah satu cara adalah dengan konferensi kasus yang melibatkan multidisipliner.
3. Saat pasien akan dipulangkan dari rumah sakit:
- a. Saat pasien tidak lagi memerlukan perawatan rumah sakit, pasien sebaiknya dipulangkan dan memperoleh *discharge planning* yang sesuai.
 - b. Yang berwenang memutuskan bahwa pasien boleh pulang atau tidak adalah DPJP.
 - c. Pastikan bahwa pasien dan keluarganya berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pemulangan pasien.
 - d. Lakukan penilaian pasien secara menyeluruh (holistik)
 - e. Nilailah kondisi fisik, mental, emosional, dan spiritual pasien
 - f. Pertimbangkan juga aspek sosial, budaya, etnis, dan finansial pasien
 - g. Tentukan tempat perawatan selanjutnya (setelah pasien dipulangkan dari rumah sakit) yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pasien.
- Penentuan tempat ini dilakukan oleh DPJP dan tim perawatan bersama

dengan penanggungjawab pasien. Berikut adalah beberapa contoh tempat perawatan:

1. Perawatan di rumah dengan penggunaan peralatan tambahan untuk menunjang perawatan pasien
 2. Pemulangan pasien ke rumah tanpa perlu perawatan khusus
 3. Perawatan di rumah dengan didampingi oleh perawat / pendamping pasien
 4. Rumah sakit / fasilitas perawatan jangka panjang
 5. Fasilitas keperawatan yang terlatih
 6. Rumah perawatan umum, seperti panti jompo, dan sebagainya.
- h. Jika tempat perawatan selanjutnya tidak memadai (tidak dapat memenuhi kebutuhan pasien), maka pasien tidak dapat dipulangkan.
- i. Tim *discharge planners* (DPJP, PPJA, MPP) harus berusaha untuk mencari tempat perawatan yang dapat menunjang kebutuhan pasien.
- j. Pastikan terjadinya komunikasi efektif antara pelaksanaan perawatan primer, sekunder, dan sosial untuk menjamin bahwa setiap pasien menerima perawatan dan penanganan yang sesuai dan adekuat.
- k. Petugas rumah sakit sebaiknya melakukan komunikasi dengan dokter keluarga pasien / tim layanan primer mengenai rencana pemulangan pasien.
- l. Identifikasi pasien-pasien yang memerlukan perawatan khusus / ekstra seperti kebutuhan perawatan kebersihan diri, sosial, dan sebagainya. Usahakan untuk memenuhi kebutuhan pasien dan berikan dukungan tambahan.
- m. Diskusikan kembali dengan pasien dan buatlah kesepakatan mengenai rencana keperawatan
- n. Finalisasi rencana keperawatan dan aturlah proses pemulangan pasien
- o. Pastikan bahwa pasien dan keluarga / pendamping telah memperoleh informasi yang adekuat.
- p. Hak pasien sebelum dipulangkan:
1. Memperoleh informasi yang lengkap mengenai diagnosis, asesmen medis, rencana perawatan, detail kontak yang dapat dihubungi, dan informasi relevan lainnya mengenai rencana perawatan dan tatalaksana selanjutnya.
 2. Terlibat sepenuhnya dalam *discharge planning* dirinya, bersama dengan kerabat, pendamping, atau teman pasien.
 3. Rancangan rencana pemulangan dimulai sesegera mungkin baik sebelum / saat pasien masuk rumah sakit.
 4. Memperoleh informasi lengkap mengenai layanan yang relevan dengan perawatannya dan tersedia di masyarakat.
 5. Memperoleh informasi lengkap mengenai fasilitas perawatan jangka panjang, termasuk dampak finansialnya.
 6. Diberikan nomor kontak yang dapat dihubungi saat pasien membutuhkan bantuan / saran mengenai pemulangannya
 7. Diberikan surat pemulangan yang resmi, dan berisi detail layanan yang dapat diakses
 8. Memperoleh informasi lengkap mengenai kriteria dilakukannya perawatan yang berkesinambungan
 9. Tim *discharge planner* (DPJP, PPJA, MPP) tersedia sebagai orang yang dapat dihubungi oleh pasien dalam membantu memberikan saran
 10. Memperoleh akses untuk memberikan complain mengenai pengaturan *discharge planning* pasien dan memperoleh penjelasannya

-
- q. Penetapan Ringkasan Pasien Pulang meliputi :
 - 1. Indikasi pasien masuk dirawat, diagnosis, dan komorbiditas lain;
 - 2. Temuan fisik penting dan temuan – temuan lain;
 - 3. Tindakan diagnostic dan prosedur terapi yang telah dikerjakan;
 - 4. Obat yang diberikan selama di rawat inap dengan potensi akibat efek residual setelah obat tidak diteruskan dan semua obat yang harus digunakan dirumah;
 - 5. Kondisi pasien (Status Present);
 - 6. Instruksi tindak lanjut
 - r. Salinan ringkasan pasien pulang minimal berjumlah empat , diperuntukkan :
 - 1. Di Rekam Medis
 - 2. Diberikan kepada tenaga Kesehatan yang bertanggung jawab memberikan tindak lanjut asuhan
 - 3. Pasien / Keluarga
 - 4. Penjamin
 - s. Ringkasan pasien pulang ditandatangani oleh Pasien/ Keluarga
 - t. Pada pasien yang ingin pulang dengan sendirinya atau pulang atas permintaan sendiri (di mana bertentangan dengan saran dan kondisi medisnya), dapat dikategorikan sebagai berikut:
 - 1. Pasien memahami risiko yang dapat timbul akibat pulang atas permintaan sendiri;
 - 2. Pasien tidak kompeten untuk memahami risiko yang berhubungan dengan pulang paksa, dikarenakan kondisi medisnya;
 - 3. Pasien tidak kompeten untuk memahami risiko yang berhubungan dengan pulang paksa, dikarenakan gangguan jiwa.
 - u. Dokumentasikan rencana pemulangan pasien di rekam medis dan berikan salinannya kepada pasien dan dokter keluarganya.
 - v. Perencanaan pemulangan pasien berisi:
 - 1. Ringkasan perawatan pasien selama di rumah sakit
 - 2. Ringkasan rencana penanganan / tatalaksana pasien selanjutnya
 - 3. Regimen pengobatan pasien
 - 4. Detail mengenai pemeriksaan lebih lanjut yang diperlukan dan terapi selanjutnya
 - 5. Janji temu dengan professional kesehatan lainnya
 - 6. Detail mengenai pengaturan layanan di komunitas / publik dan waktu pertemuannya
 - 7. Nomor kontak yang dapat dihubungi jika terjadi kondisi emergensi / pembatalan pertemuan / muncul masalah-masalah medis pada pasien.
 - w. Tindak lanjut pemulangan pasien yang memerlukan rujukan kepada fasilitas kesehatan primer atau mandiri sesuai domisili pasien : Pasien dengan status post rawat inap / KRS (Keluar Rumah Sakit) untuk kontrol pertama setelah rawat inap maka pasien langsung kontrol ke poli sesuai dengan DPJP yang merawat pasien tersebut, untuk kontrol selanjutnya apabila kondisi pasien sudah stabil maka akan di PRB kan (Pasien Rujuk Balik) oleh DPJP terkait.
 - x. Rencanakan dan aturlah pertemuan selanjutnya dengan pasien

BAB IV
EVALUASI

Monitor dan evaluasi efikasi dan kelayakan perencanaan pemulangan pasien secara periodik, dengan cara:

- a. Peninjauan ulang rekam medis / catatan pasien
- b. Gunakan *checklist* untuk menilai perkembangan dan kemajuan *discharge planning*
- c. Lakukan perencanaan ulang, jika diperlukan

Peninjauan ulang dan audit harus dilakukan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa panduan berjalan dengan lancar dan diterapkan oleh seluruh professional kesehatan di rumah sakit.

Lampiran 1

PERENCANAAN PASIEN PULANG

Tanggal MRS	Pukul..... WIB	Tanggal KRS	Pukul WIB		
Kriteria Pasien Yang Membutuhkan Perencanaan Pasien Pulang : ☐ Balita ☐ Usia lanjut (60 tahun atau lebih) dengan ☐ Hambatan mobilisasi dengan ☐ Membutuhkan pelayanan medis dan perawatan berkelanjutan dengan ☐ Tergantung dengan orang lain dalam aktivitas harian dengan *) Jika salah satu terpenuhi, berarti pasien membutuhkan perencanaan pulang khusus					
Transportasi pulang : ☐ Pribadi : ke ☐ Umum : ke ☐ Ambulance : ke		Orang yang mendampingi & merawat pasien di rumah :			
Pengobatan yang dilanjutkan di rumah					
Nama Obat	Rute	Jumlah	Dosis	Jam pemberian	Instruksi Khusus
Diet Khusus Pasien :					
Perawatan / peralatan medis yang dilanjutkan di rumah					

☐ Perawatan Luka : ☐ Penggunaan Insulin: ☐ Pemakaian Kateter : ☐ Pemakaian NGT : ☐ Memandikan Bayi :	☐ Menjemur Bayi : ☐ Perawatan Tali Pesar : ☐ ☐ ☐	
Alat bantu yang dipakai di rumah : ☐ Kursi Roda ☐ Tongkat ☐		
Pendidikan kesehatan untuk di rumah		
☐ Balutan jangan basah / kotor ☐ Hindari mengangkat beban berat ☐ Jangan mengendarai kendaraan sendiri / menyupir ☐ Cek laboratorium sebelum kontrol ☐ Jangan menaiki tangga lebih dari dua atau tiga kali sehari ☐ Batasi pekerjaan rumah tangga dan kegiatan sosial, melakukan aktivitas secara bertahap sampai kesehatan pulih kembali ☐ Jika muncul keluhan nyeri atau rasa sakit tidak berkurang dengan obat anda atau menjadi lebih buruk, segera datang ke RS / fasilitas kesehatan terdekat		
Diberikan kepada pasien / Keluarga	Jadwal control berikutnya	
☐ Obat – obatan ☐ Peralatan / barang pribadi ☐ Resep obat ☐ Hasil pemeriksaan penunjang ☐	Nama Dokter : Tanggal : Pukul WIB Tempat : ☐ Poli ☐ IGD	
Instruksi diberikan kepada : ☐ Pasien ☐ Keluarga ☐ Orang terdekat ☐ Lain – lain	Saya dapat menerima dan mengerti tentang instruksi pulang.	
	Pasien/Keluarga (.....)	Petugas RS (.....)

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 04 April 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,

dr. Nur Mazidah